

Psychotropes et constipation

 La constipation est un effet indésirable très fréquent des traitements psychotropes, dont l'identification et la prise en charge sont essentielles.

? Poser la question « êtes vous constipé.e ? » n'est pas toujours suffisant, car la définition de la constipation est variable selon les personnes. Des outils d'évaluation standardisés peuvent être utiles :

- ▶ échelle visuelle de Bristol
- ▶ critères ROME IV (< 3 selles/semaine avec selles dures, sensation de blocage, de vidange incomplète, etc.)

? La constipation est difficile à identifier chez les personnes avec des troubles de la communication. Il faut y penser systématiquement devant une modification récente du comportement (agitation, prostration, etc) ou un syndrome confusionnel.

 La charge anticholinergique est le principal facteur responsable de la constipation liée aux psychotropes. La motricité du tube digestif est diminuée, ce qui augmente le temps de transit colique. Plusieurs psychotropes ont une forte activité anticholinergique :

- ▶ antipsychotiques : clozapine, levomépromazine, cyamemazine
- ▶ antiparkinsoniens « correcteurs » : tropatepine, trihexyphenidyl, biperiden
- ▶ antidépresseurs tricycliques : clomipramine, amitriptyline, etc.
- ▶ anxiolytiques : hydroxyzine

 Plus le nombre et la dose de ces traitements sont élevés, plus le risque de constipation augmente. La durée du traitement n'a pas d'influence.

 D'autres facteurs augmentent la constipation : faible hydratation, alimentation pauvre en fibres, sédentarité, mauvais état dentaire.

! Une constipation non prise en charge peut avoir un retentissement majeur sur la qualité de vie (inconfort, douleur) et exposer à des complications sévères (occlusion ou « syndrome d'Ogilvie »).

- ! les mesures hygiéno-diététiques sont indispensables
- ! des massages coliques réalisés par un.e kinésithérapeute sont très utiles
- ! ces mesures sont souvent insuffisantes si la charge anticholinergique n'est pas réduite au maximum. Pour la clozapine, il est souhaitable d'arrêter le plus rapidement possible les autres traitements anticholinergiques (« correcteurs » antiparkinsoniens, cyamémazine, hydroxyzine) et de vérifier que la clozapinémie est < 600 ng/ml.

 La prescription de laxatifs est souvent nécessaire mais ! Ils ne sont pas tous indiqués dans la constipation liée à la charge anticholinergique. On recommande :

- ▶ en 1^{ère} ligne les laxatifs osmotiques (lactulose, macrogol, etc.)
- ▶ en 2^{nde} ligne les laxatifs stimulants (séné, bisacodyl, etc.), par voie rectale, ou des lavements
- ▶ ! de ne pas prescrire de laxatifs de lest (sterculia, psyllium, etc.) qui augmentent le risque occlusif, surtout si l'hydratation est insuffisante !

- en cas de risque occlusif, d'autres stratégies sont possibles (agoniste cholinergique) après avis spécialisé.
- un analogue des prostaglandines (lubiprostone non disponible en France) est préconisé dans la constipation liée à la clozapine

🧊 Lors de l'introduction de la clozapine, la prescription préventive de laxatif peut être envisagée si la constipation est difficile à identifier, ou si on ne peut pas réduire la charge anticholinergique.

Références ↓

<https://doi.org/10.1007/s40263-021-00859-0>

<https://doi.org/10.1007/s40263-017-0481-5>

